

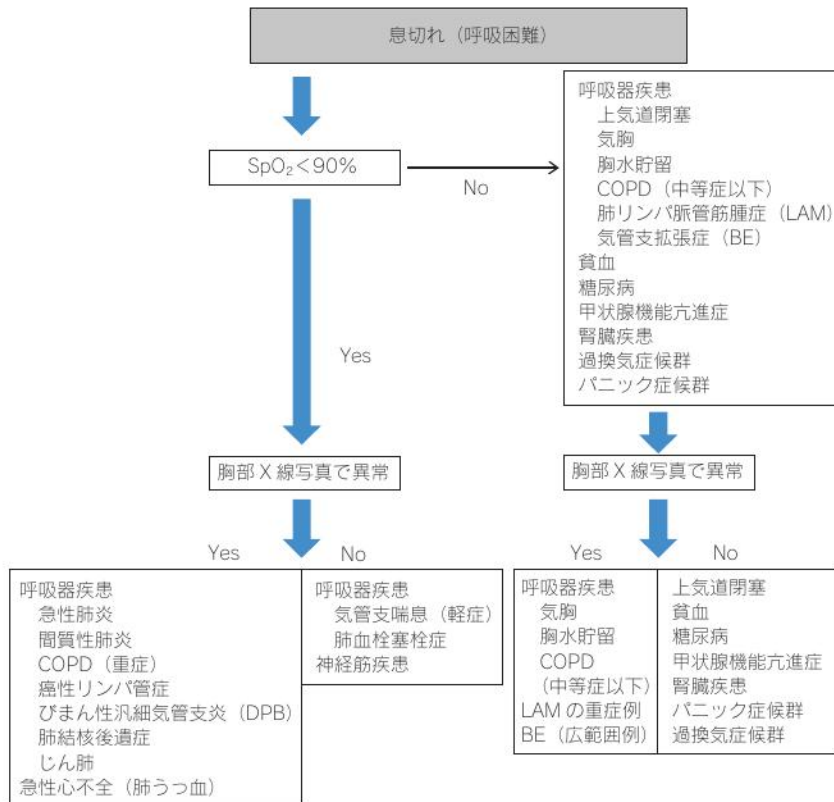


図1 パルスオキシメータと胸部X線写真による呼吸困難の鑑別診断
(ただし疾患は代表例のみ記載)

吸困難の程度として、modified Medical Research Council (mMRC, Grade 0~4; 4のほうが息切れが強い) による基準を用いることが多い。

ii) 発症状況

長期臥床後であれば、肺血栓塞栓症、食事後であれば、高齢なら誤嚥や窒息を、若年であれば食物アレルギー（アナフィラキシー）、また夜間においては、就寝直後あるいは明け方であれば喘息発作、夜間から明け方であれば心不全などを考えなければならない。また、肺炎が疑わしい場合であれば、原因としてペットや温泉旅行の有無、また過敏性肺炎では住居環境および羽毛製品の問診が重要である。

iii) 随伴症状の有無

咳・痰や胸痛があれば、呼吸器ないし心臓由来の疾患をより強く疑う。胸痛があれば、胸膜炎・心膜炎あるいは肺梗塞・心筋梗塞・心筋炎なども考慮する。発熱を伴う場合は肺炎や間質性肺炎など炎症やアレルギー性疾患も考慮でき、血痰・咯血は、肺癌や肺血栓塞栓症を考慮する。また合併症の聴取は重要で、糖尿病・腎疾患（ケトアシドーシスや尿毒症性肺水腫）貧血、神経筋疾患の有無、精神疾患（過換気症候群）などがあれば、それによる息切れも鑑別となる。

b) 身体所見

i) バイタルサインのチェック

問診と同時にねばならないが、呼吸数と呼吸パターンは重要であり、前者は頻呼吸（25回/min以上）、徐呼吸（12回/min以下）などに分かれる。頻呼吸は、呼吸困難を伴う呼吸器疾患や心不全また不安などによることもある。徐呼吸は頭蓋内圧亢進やCO₂ナルコーシス時にみられる。また呼吸パターンとしては、Kussmaul呼吸（糖尿病性ケトアシドーシス）、過呼吸（過換気症候群）、口すぼめ呼吸や呼吸補助筋の使用〔慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease: COPD）〕、Cheyne-Stokes呼吸や起坐呼吸（心不全）などが疾患と直結する。

ii) 視診・聴診

チアノーゼやパチ指は慢性の低酸素血症を、頸静脈怒張や浮腫は右心不全を疑わせる。聴診ではwheezesは喘息、cracklesは心不全や間質性肺炎を考える所見となる。

c) 検査の選択

i) 必須の検査とそれによる鑑別

必須の検査として、胸部X線、血算、血液ガス（パルスオキシメータ）、心電図があり、それらの組み合わせによってかなりの呼吸困難の鑑別は可能である。